

AFMCP 챕터4 | ABCDs 영양평가 – D: 식이·생활방식 일지

식이·영양·생활방식 일지 활용법 + 통합 케이스

1. 식이·영양·생활방식 일지 (Diet, Nutrition & Lifestyle Journal)

IFM이 제공하는 이 도구는 환자의 실제 식이·생활방식을 파악하는 탁월한 방법입니다. 최소 3일(가능하면 7일)을 기록하도록 권장합니다.

일지가 제공하는 정보

- 식이 패턴·습관 파악
- 식품·음료 선택 확인
- 식사 시간·양 파악 (하루 후반부 칼로리 집중 = 인슐린저항성 유발)
- 일주기리듬(circadian rhythm)과 연관된 패턴 파악
- 매 식사 단백질 여부 및 식이섬유 양 확인
- 운동·수면·정신적·정서적·영적 안녕 기록

일지 구성

- 상단: 식품·음료 섹션 (시간, 거대영양소, 파이토뉴트리언트 R-O-Y-G-B-P + 흰/갈색)
- 중단: 수정 가능한 생활방식 요인 (운동, 수면, 스트레스)
- 하단: 정신적·정서적·영적 안녕

2. 식이일지 분석 예시: 채식주의자 43세 여성

채식 20년, 체중·피로 주訴, 심장질환·고콜레스테롤·고혈당 가족력

시간	식품	주요 문제점
아침	커피,オート밀, 토스트+버터	단백질 없음 → 혈당 급상승·급하강, 파이토뉴트리언트 부족 (흰/갈색만)
11시 간식	머핀, 오렌지주스	과즙 → 섬유질 없이 당분만, 정제 탄수화물
점심 1시	맥앤치즈, 사과, 우유	탄수화물 과다, 단백질 적음, 사과로 빨강 체크
오후 4시 간식	감자칩, 탄산음료	초가공식품, 공허한 칼로리
패턴 요약	탄수화물 과다, 단백질·지방·파이토뉴트리언트 부족, 탄산음료·주스 과다	→ 인슐린저항성·대사증후군 위험

3. ABCDs 통합 케이스 (동일 환자)

항목	소견	의미
----	----	----

A: 인체측정	BMI 과체중(>25), 허리둘레 37인치, 허리/엉덩이비율 0.9 (모두 상승)	복부비만, 대사증후군·인슐린저항성 위험
B: 바이오마커	알부민 저하 (단백질 부족) LDL 상승, 오메가3 저하 중성지방 상승, TG/HDL비율 상승, 공복혈당 >100 헤모글로빈·헤마토크릿 저하, 알칼리인산분해효소 저하 MCV 상승 (B12 의심) ALT·AST 상승 (비알코올성 지방간 의심)	복합 영양 결핍: 단백질·오메가3·철·아연·B12 부족 대사증후군 확인
C: 임상검진	가는 모발, 취약한 손톱, 구강염(단백질 부족) 건조·각질 피부, 과각화증(필수지방산 부족) 치아우식, 흑색가시세포증(인슐린저항성) 백색조갑반점, 아프타성 구내염	영양 결핍 다발성 확인
D: 식이일지	가공식품 다수, 달걀 없음 불건강한 지방, 정제 탄수화물·단당류 식물성 단백질 부족 → 미네랄·비타민 부족	채식이어도 건강 식이와는 거리가 있음

4. 중재 방향

- 정제 탄수화물 줄이고 파이토뉴트리언트 늘리기
- 매 식사 단백질 추가로 혈당 균형
- IFM 기능의학 처방 및 생활방식 계획 양식 활용
- 운동 계획, 스트레스 감소 계획 병행

결론: ABCDs 통합 평가로 환자의 강점과 취약 영역을 파악하고, 적절한 식이 중재로 건강 목표 달성을 지원합니다.